

Тестовое задание — бизнес-ассистент руководителя

Clean Clinic Nord · Санкт-Петербург, Шуваловский пр., 41 · Приморский район

Это черновик с моими мыслями. Я специально пишу простым языком и от первого лица — где я чего-то не знаю, я так и пишу «надо уточнить». Мне важнее показать ход мысли, чем сделать вид, что я знаю всё про вашу клинику.

Пара слов, от чего я отталкивался

Прежде чем писать, я посмотрел ваш сайт, карточку на Яндекс.Картах, фото входа и клиентской зоны, и сравнил с другими клиниками капельниц в Питере.

Что для меня важно и красной нитью идёт через все три задачи:

- **Ваша аудитория — взрослые люди 50+**, и они ищут не в соцсетях, а на картах и по отзывам. Значит, воевать надо там.
 - **Люди ищут простыми словами.** «Капельница от усталости», «прокапаться витамины», «сдать анализы рядом». Слово «инфузионная терапия» обычный человек в поиск не вбивает.
 - **У вас уже есть база 1000+ пациентов и цикличный продукт** — курсы капельниц надо повторять. Это, на мой взгляд, ваш самый недоиспользованный актив. Новый клиент стоит дорого, а эти люди вам уже доверяют.
 - **Вы думаете про сеть и франшизу.** Поэтому я старался предлагать не разовые костыли, а вещи, которые можно превратить в стандарт и повторить в следующей клинике.
-

Задача 1. Как продвигать именно эту клинику в 2026

а) Базовые инструменты — то, что просто обязано работать

1. Яндекс.Карты + 2ГИС (для вас это канал №1, а не «ещё один пункт»). Зачем: ваша аудитория 50+ принимает решение прямо здесь — сравнивает клиники по отзывам, рейтингу и фото. У вас уже 5.0 и 118 отзывов на Картах — это сильный актив, но его надо доить и держать свежим. С чего начать: до конца заполнить карточку (все услуги, часы, фото, цены), добавить рубрики и услуги понятными словами — «капельницы», «анализы», «чек-ап», а не только «инфузионная терапия». Отвечать вообще на все

отзывы. И системно просить довольных людей оставлять отзыв (QR на ресепшене, СМС после визита). Свежесть отзывов Карты любят даже больше, чем их количество.

2. Сайт под понятные запросы (SEO). Зачем: сейчас сайт говорит «инфузионная терапия», а люди в поиске набирают «капельница детокс спб», «прокапаться приморский район». Вы просто не попадаетесь им на глаза. С чего начать: под каждую услугу — отдельная страница простым языком, с ценой и составом капельницы. Слово «инфузионная терапия» оставить, но рядом обязательно «капельницы». По-хорошему — привязка к району: «капельницы в Приморском районе / у Шуваловского».

3. Яндекс.Директ с гео на район. Зачем: пока SEO раскачивается (это месяцы), контекст даёт трафик уже завтра. С чего начать: кампании на «капельница», «сдать анализы», гео 3–5 км вокруг клиники, посадочные под конкретную услугу. Честная оговорка: медтематика на модерации строгая, нужна лицензия в кабинете и аккуратные формулировки без обещаний «вылечим». Это я бы проверил в первую очередь.

4. Карточки на ПроДокторов / НаПоправку. Зачем: для медицины это отдельная витрина доверия. Люди 50+ читают отзывы не только о клинике, но и о конкретном враче. С чего начать: завести и заполнить карточки клиники и ваших врачей (Устинова, Бган, Братусь), собрать туда первые отзывы.

5. CRM и работа с базой. Зачем: без CRM база 1000+ — это просто список, который лежит мёртвым грузом. С CRM это машина повторных продаж. Это мостик к пункту «в». С чего начать: свести всех пациентов в одну систему, проставить, кто на какую услугу приходил и когда.

б) Новое, что стоит попробовать именно вам (2025–2026)

1. Реактивация базы через мессенджеры и ботов — для вас это, честно, самое вкусное. Как работает: курс капельниц цикличен. Детокс, иммунитет, антистресс — это не разово, это надо повторять по сезону. Бот/рассылка в WhatsApp и Telegram сама напоминает: «прошло 3 месяца, пора повторить курс поддержки печени». Кстати, я заметил на вашей стойке прайс идёт колонками 1/3/5 процедур — то есть курс у вас уже зашит в цену. Значит, повторные продажи — это ваша родная механика, её надо просто включить. С чего начать: выгрузить базу, разбить по услугам, настроить понятные напоминания. Тон — спокойный и заботливый, без «успей купить», для 50+ это важно.

2. Управление репутацией как процесс, а не разовая акция. Как работает: не «попросили пару отзывов», а система — каждому после визита уходит просьба, негатив перехватывается до того, как он попадёт в Карты. Для локального бизнеса свежие отзывы 50+ аудитории = верхние строчки в поиске. С чего начать: простой сценарий после визита (СМС/мессенджер), шаблоны ответов, ответственный человек.

3. Короткие видео-отзывы и понятный контент от «своих». Как работает: живой отзыв женщины 55+ «пришла уставшая, прокапалась курсом, стало легче» работает на вашу аудиторию в разы лучше, чем красивая картинка. Плюс короткие ролики/посты «что такое чек-ап простыми словами». С чего начать: снять 3–5 реальных историй пациентов (с согласия), выкладывать в Карты, VK и Telegram-канал клиники.

ИИ-инструменты для генерации текстов под карточки и SEO я бы тоже использовал — но аккуратно и с проверкой, в медицине нельзя публиковать сгенерированную отсебятину. Это скорее ускоритель рутины, чем отдельный канал.

в) Если бы запускал я — 3 приоритета на первый месяц

- 1. Навести порядок в Картах и отзывах.** Дёшево, быстро и бьёт прямо в вашу аудиторию 50+, которая принимает решение именно там. Это фундамент, без него платный трафик — деньги на ветер.
- 2. Разбудить базу 1000+ через рассылку про повторные курсы.** Это самый дешёвый доход, который у вас есть: люди уже вам доверяли. Даже небольшая доля вернувшихся окупает всё остальное (грубая прикидка ниже).
- 3. Переписать сайт и карточки на человеческий язык** — «капельницы», «анализы», «чек-ап», а не «инфузионная терапия». Иначе весь трафик, за который мы платим, утекает, потому что люди нас просто не находят по своим словам.

Почему именно эти три: они почти без бюджета, все три сразу можно оформить как стандарт для будущей сети, и они лечат корневую проблему — вас плохо находят и вы не дожидаете тех, кто уже был.

Сравнение с конкурентами (Питер)

Я посмотрел, кто ещё делает капельницы в городе:

Клиника	Позиционирование	Цена (со слов сайта)
XXI век	сетевая клиника, детокс-капельницы	детокс от ~2 080 ₽
Капельницы Здоровья	детокс-центр, на дому и в клинике	от ~2 000 ₽
BIORISE	капельницы/детокс	от ~4 100 ₽
IV-Health	отдельная клиника капельниц	акцент на «выгодную цену»
СМ-Клиника, Источник Долголетия	крупные сети, IV как доп. услуга	средний+ сегмент

Что я из этого вынес: **рынок капельниц в Питере плотный, и многие демпингуют — «от 2000 ₽»**. Лезть в ценовую войну вам нельзя, вы её не выиграете у сетей. Ваша отстройка — не «капельница дешевле всех», а **программа здоровья для взрослого человека**: превентив + чек-апы + курсы + сервис и забота под аудиторию 50+. Продавать надо не литр раствора, а «поддержку здоровья по возрасту». *Оговорка: цены у всех «от» — это маркетинг. Реальный средний чек конкурентов я не знаю, это надо смотреть отдельно, я привёл то, что видно на их сайтах.*

Задача 2. Проблема с колл-центром

а) Разбор — почему это проблема процесса, а не «попались не те люди»

Ситуация: три недели подряд набираете по 1–2 удалённых оператора, РОП лично их вводит, они начинают звонить, через пару дней уходят. И так по кругу.

Вот что мне тут бросается в глаза. **Когда уходит один человек — это про человека. Когда уходят все и одинаково быстро — это уже про процесс.** Стабильный повторяющийся результат не может быть случайностью «не тех людей». Значит, дело в условиях, в которые мы этих людей ставим.

Мои гипотезы, почему они уходят (это именно гипотезы, я бы их проверял, а не считал фактом):

- **Оператору не с чем работать.** Если база холодная или сырая — человек два дня получает отказы, выгорает и уходит. На отказах без поддержки долго никто не сидит.
- **Нет онбординга и опоры.** Удалёнщик сидит один дома. Ваш продукт непростой — чек-ап «Железная леди», «Мужское здоровье», курсы капельниц надо понимать, чтобы объяснить человеку 50+. За два дня в это не въедешь. Нет скрипта и базы знаний — оператор чувствует себя брошенным.
- **РОП «на связи» = ручное управление.** Со стороны оператора это часто ощущается как контроль и давление, а не помощь. А со стороны РОПа — это выжигание его собственного времени.
- **Мотивация не бьётся с усилием.** Если оклад маленький, а бонус далёкий и непонятный — смысла терпеть тяжёлые звонки нет.

Чего не хватает, чтобы поставить точный диагноз (и это я честно сказал бы руководителю первым делом): у меня нет ваших цифр. Я бы попросил:

- **exit-интервью** с теми, кто ушёл — прямой вопрос «почему?». Часто ответ вообще не тот, что мы думаем.
- **записи звонков** — где именно ломается разговор.

- **цифры по операторам** — сколько звонков, сколько дозвонков, сколько записей, какая конверсия, за что и сколько мы платим.

Без этого мы лечим вслепую. И ещё важное: **РОП здесь — узкое место**. Каждый новый заход обнуляет то, что он вложил, и он не делает свою настоящую работу — не управляет отделом. Это замкнутый круг, и рвать его надо не «ещё одним набором», а сменой модели.

б) Что бы я делал по шагам

Шаг 0. Диагностика (примерно неделя). exit-интервью с ушедшими, послушать звонки, собрать те самые цифры. Без этого дальше — гадание.

Шаг 1. Определиться с моделью колл-центра. Тут я опираюсь на свой опыт.

Я работал в рекламном агентстве, и там была выстроена хорошая работа с **внешним колл-центром** — натренированной опытной командой подрядчика. Я вёл с ними коммуникацию: ставил задачи, передавал скрипты, следил за качеством. И главное наблюдение оттуда: **опытный подрядчик уже умеет звонить**. Его не надо каждый раз обучать с нуля, и его текучка — это его проблема, а не ваша. Вы платите за результат, а не за нянчение новичков.

Отсюда мой основной вариант для клиники — **гибрид**:

- **Внешний колл-центр (аутсорс)** — на первичный обзвон, реактивацию базы 1000+, подтверждение записей и напоминания. То, где нужен объём и навык звонка.
- **Свои администраторы** — на тёплую линию: входящие, запись, работа с 50+ живую, допродажа курса. То, где нужны продукт, эмпатия и лицо клиники.

Плюсы: закрываем дыру быстро, снимаем с РОПа роль няньки, текучку отдаём подрядчику. Минусы и оговорки (честно): подрядчик хуже знает ваш продукт — значит, нужен хороший скрипт и обучение подрядчика (я это делал, готов взять на себя). И жёсткое правило: **аутсорсу нельзя давать медицинские консультации** — только запись и логистика, любые вопросы про здоровье переводим на своих. Это и юридически, и по доверию критично.

Альтернатива — строить свой колл-центр правильно (нормальный онбординг 1–2 недели, скрипты, база знаний, вменяемая мотивация, не бросать человека одного). Это можно, но дольше и дороже. Я бы начал с гибрида, чтобы быстро остановить кровотечение, а свою тёплую линию из 1–2 сильных админов растил параллельно.

Шаг 2. Автоматизировать, чтобы снизить саму нагрузку на колл-центр. Это, по-моему, половина решения. Куча звонков — это рутина: подтвердить запись, напомнить о визите, напомнить о повторном курсе. Всё это может делать **бот** в мессенджерах. Тогда живые операторы занимаются только тем, где реально нужен человек. Смысл не в том, чтобы «нанять больше операторов», а в том, чтобы **убрать половину звонков**

ботом. С чего начать: боты на подтверждение записи и напоминания о визите, автоответы в WhatsApp/Telegram, напоминание «пора повторить курс» (это ещё и продажи — см. Задачу 1).

Шаг 3. Поставить метрики и управлять по цифрам. Простой дашборд: звонки, дозвонки, записи, дошли, конверсия, стоимость записи. Плюс записи разговоров и короткий еженедельный разбор. Тогда РОП управляет по цифрам, а не сидит нянькой рядом с каждым новичком.

Мысль под франшизу: у сетевых клиник Питера (та же СМ-Клиника, XXI век) обычно единый контакт-центр на все филиалы плюс общая CRM. Вам под сеть всё равно придётся к этому прийти. Так что централизованный КЦ + CRM + скрипты лучше закладывать как стандарт уже сейчас, на первой клинике, а не переделывать потом на трёх.

Задача 3. Входная группа и клиентская зона

Главная мысль: **снаружи вы теряете клиента ещё до входа, а внутри немного путаете его в том, кто вы.** Для аудитории 50+ и для будущей франшизы это критично — вход должен и находиться, и «продавать», и потом легко повторяться в следующей клинике.

Ниже — мои наблюдения по фото и что я бы с этим делал.

1. Вывеску не видно, вход не найти. Что вижу: на фасаде у вас только маленький лайтбокс «АНАЛИЗЫ» и крошечная табличка «КЛИНИКА» у самой двери, под козырьком. Вход утоплен, лестница сбоку. Человек 60 лет с картой в руке встанет у дома и не поймёт, куда идти. А прохожий вас вообще не заметит — то есть неохваченная аудитория проходит мимо. Решение: полноценная вывеска на фасад со стороны лестницы/входа, на уровне глаз, видимая с тротуара. Плюс навигация: указатель-стрелка от угла дома к лестнице и крупная табличка на входной двери. Под франшизу — сделать это шаблоном «входная группа»: где вывеска, какого размера, что на двери. Чтобы в следующей клинике не изобретать заново.

2. В глаза бросается прачечная, а не клиника. Что вижу: рядом огромная светящаяся синяя вывеска «СТИРАЛКА — прачечная, химчистка». Она перебивает вас полностью. Взгляд цепляется за прачечную, а клиника теряется. Решение: соседа убрать нельзя, но внимание можно перетянуть. Вашу вывеску сделать крупнее и с подсветкой (для 50+ вечером это важно), в своей спокойной гамме, чтобы не спорить с синим, а выделяться на его фоне. Слово «АНАЛИЗЫ» я бы оставил как якорь — оно людям понятно, — но добавил бы «Клиника · Капельницы · Чек-ап».

3. Название на латинице непонятно, особенно старшим. Что вижу: «CLEAN CLINIC» золотыми буквами — красиво, но человек 50+ латиницу не читает и не понимает, что

это и зачем ему. А «инфузионная терапия» — тем более. Решение: из вывески за 2 секунды должно читаться — это медицина, и вот какую мою потребность она закрывает. Я бы не стал ломать бренд (он уже засветился в Картах с рейтингом 5.0, это жалко терять), а **добавил бы рядом читаемую русскую строку с понятным дескриптором**: «Клиника здоровья · Анализы · Капельницы · Чек-апы». Полностью переименовывать на русское — это уже ваше решение, тут я не настаиваю, но русский пояснитель нужен точно.

4. Внутри похоже на салон красоты. Что вижу: золотая люстра-одуванчик, золотые буквы, серые бетонные стены, надпись на стене «Относись к себе как к произведению искусства». Красиво — но это язык бьюти-салона, а не клиники. Человек 50+, который пришёл за здоровьем, может считать это как «дорого и несерьёзно». Решение: сместить палитру в спокойные «медицинские» тона — мягкий зелёный, приглушённый голубой, тёплый белый. Дерево можно оставить, оно тёплое и уместное. Золото приубрать. И добавить маркеры доверия, которых сейчас не видно: лицензия на видном месте, дипломы врачей, таблички услуг простым русским языком. Атмосфера должна говорить «тут чисто, спокойно и профессионально», а не «тут гламур».

5. Плюс, который у вас уже есть — и как его усилить. Что вижу и что мне понравилось: витрина с продукцией (SUPERMAN, поддержка печени, иммунитет) и зона ожидания с креслами, водой, цветами, журналами. Это реально хорошо и работает на средний чек — многие клиники до этого не доходят. Как усилить: - На витрине — **ценники и короткое «зачем это» человеческим языком**. Люди 50+ не купят то, чего не понимают. Можно мини-QR на страницу услуги. - В зоне ожидания вместо глянца — **свой мини-журнал/памятки**: «когда повторять курс», «что такое чек-ап простыми словами». Это и образовывает, и мягко допродает. - Тёплый чай, пробники — для вашей аудитории это считывается как забота, а не как «впаривание». - **Учесть возраст физически**: крупный шрифт на всех табличках, поручень у лестницы снаружи (по фото есть перила у пандуса — надо проверить, удобно ли), и пара кресел повыше и с подлокотниками. Сейчас кресла низкие и без подлокотников — человеку 50+ из такого тяжело вставать. Мелочь, но именно из таких мелочей складывается «здесь думают о таких, как я».

Под франшизу: всё это я бы собрал в «**стандарт клиентской зоны**» — чек-лист, что должно быть в каждой клинике сети: палитра, вывеска и навигация, витрина с ценниками, зона ожидания, поручни, крупный шрифт. Тогда вторая и третья клиника открываются по шаблону, а не с нуля.

Что я бы уточнил у руководителя (честно, чего мне не хватило)

- Ваши реальные цифры по колл-центру — без них Задача 2 наполовину догадки.
- Средний чек и цены на курс — чтобы прикинуть доход от реактивации базы точными числами, а не диапазоном.
- Есть ли уже CRM и в каком виде лежит база 1000+.
- Юридические рамки по рекламе медуслуг — что можно писать в Директе и на картах.

Прикидка «на салфетке» по базе (числа условные, надо подставить ваши): капельница на рынке ~2 000–5 000 ₽, курс из 5–10 процедур ~15 000–40 000 ₽. Если вернуть на повторный курс хотя бы 10% базы — это ~100 человек. При среднем чеке курса ~20 000 ₽ это порядка 2 млн ₽ выручки почти без затрат на привлечение. Даже если я ошибаюсь в разы — порядок понятен, и это дешевле любой новой рекламы.